TUBE DIGESTIF · DI-03

# Appendicite aiguë · WSES 2025

**WSES Jerusalem 2025**
choix de l'imagerie, signes, formes compliquées

**Démarche WSES 2025 :** d'abord un **score clinico-biologique** (AIR, AAS chez l'adulte, PAS chez l'enfant). Risque faible : appendicite peu probable, observation. Risque intermédiaire : **imagerie** ou observation active. Présentation atypique : le **scanner** reste l'examen de référence (meilleure sensibilité).

## CHOIX DE L'IMAGERIE SELON LE PATIENT

| PATIENT | 1RE INTENTION | SI NON CONTRIBUTIF OU DOUTE PERSISTANT |
|---|---|---|
| **Adulte** | **Scanner faible dose** (< 2–3 mSv) si disponible ; échographie + score en alternative | Scanner |
| **Enfant, adolescent** | **Échographie** | Scanner faible dose |
| **Grossesse** | Échographie | **IRM** (sans gadolinium) |
| **Obésité (IMC ≥ 30), ≥ 65 ans** | **Scanner**, de préférence faible dose, plutôt que l'échographie | — |

## SIGNES D'APPENDICITE

### Échographie (compression graduée)

- Appendice **> 6 mm**, borgne, **non compressible**
- Paroi épaissie, hypervascularisée en Doppler
- Graisse péri-appendiculaire hyperéchogène
- Stercolithe : image hyperéchogène avec cône d'ombre
- Douleur au passage de la sonde

### Scanner

- Appendice distendu **> 6 mm**, paroi épaissie et rehaussée
- Densification de la graisse péri-appendiculaire
- Épaississement du bas-fond cæcal
- Liquide de voisinage, ganglions réactionnels
- Injection IV ; opacification digestive non nécessaire

### IRM (grossesse)

- Mêmes critères morphologiques que le scanner
- Hypersignal T2 de la paroi et de la graisse, restriction de diffusion
- Appendice normal : rempli d'air ou de contenu, < 6 mm

## APPENDICITE COMPLIQUÉE : CE QUI CHANGE LA PRISE EN CHARGE

| DÉFINITION WSES | SIGNES AU SCANNER | CONSÉQUENCE HABITUELLE |
|---|---|---|
| **Perforation** | **Défect focal de la paroi rehaussée** (signe le plus sensible), air extraluminal, stercolithe extraluminal | Chirurgie ; antibiothérapie postopératoire courte (2–3 jours) |
| **Abcès** | Collection péri-appendiculaire à paroi rehaussée (signe le plus spécifique) ; taille et accessibilité au drainage | < 35 ans : appendicectomie précoce. **≥ 35 ans** : traitement non opératoire puis **appendicectomie à 6–12 semaines** (néoplasie appendiculaire jusqu'à 14,3 %) |
| **Péritonite diffuse** | Liquide diffus, rehaussement péritonéal, pneumopéritoine | Chirurgie rapide |
| **Gangrène étendue** | Défaut de rehaussement pariétal | Chirurgie |

Le **stercolithe** est un facteur de risque de perforation et d'échec du traitement antibiotique, mais il ne suffit pas à définir une forme compliquée. Avant appendicectomie différée après abcès : scanner (résolution) et coloscopie, surtout après 35 ans.

## PIÈGES ET DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS

### Appendice difficile à voir

- Position rétro-cæcale ou pelvienne : suivre le cæcum jusqu'à la base
- Appendicite de la pointe : examiner l'appendice sur toute sa longueur
- Appendice non vu sans signe indirect : n'exclut pas formellement, mais rend le diagnostic moins probable

### Autres causes de douleur de la fosse iliaque droite

- Adénolymphite mésentérique, iléite infectieuse ou maladie de Crohn
- Torsion d'annexe, kyste rompu, grossesse extra-utérine
- Diverticulite droite, appendagite épiploïque, colique néphrétique

## COMPTE RENDU

**Appendice**
vu ou non, position, diamètre

**Inflammation**
paroi, graisse, stercolithe (siège)

**Complication**
défect, air, abcès (taille, voie de drainage), liquide

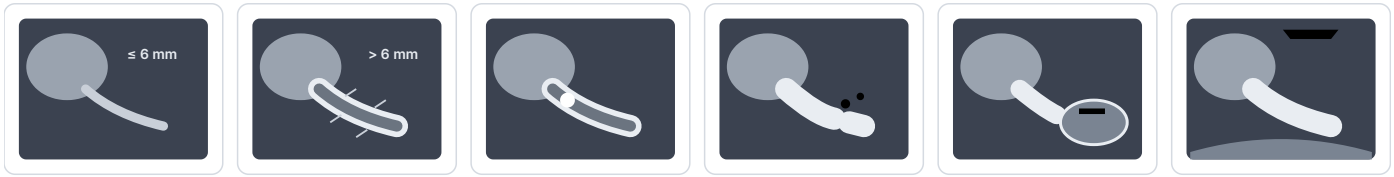
**Alternative**
autre diagnostic si appendice normal

# Appendicite aiguë · WSES 2025 (suite)



## ATLAS VISUEL

**Appendice au scanner : du normal au compliqué**




**Normale**
air ou contenu, paroi fine

**Non compliquée**
distension, densification

**Stercolithe**
facteur de risque, non suffisant

**Perforation**
défect pariétal, air extraluminal

**Abcès**
collection à paroi rehaussée

**Péritonite**
liquide diffus ± pneumopéritoine

Schémas simplifiés, non à l'échelle · gris clair = paroi rehaussée, noir = air

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Appendicite : synthèse**
Radiopaedia · écho, scanner, IRM
radiopaedia.org/articles/appendicitis-summary

**Appendicite aiguë**
Radiopaedia · article de référence
radiopaedia.org/articles/acute-appendicitis-2

**Appendice perforé**
Radiopaedia · signes de perforation
radiopaedia.org/articles/perforated-appendix

**Stercolithe**
Radiopaedia · aspect écho et scanner
radiopaedia.org/articles/appendicolith?lang=us

**Perforation avec abcès (cas)**
Radiopaedia · cas scanner
radiopaedia.org/cases/perforated-appendicitis-wi

**WSES Jerusalem 2025**
PubMed · recommandations
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41604201/

**Sources :** Podda et al., WSES Jerusalem Guidelines 2025 (JAMA Surg 2026) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41604201/ · Radiopaedia – perforated appendix – radiopaedia.org/articles/perforated-appendix · Radiopaedia – appendicitis (summary) – radiopaedia.org/articles/appendicitis-summary